診所論文摘要

2026年11月13日朝早簡報

五篇同行評審研究的中文摘要

這份合集把今日五篇論文改寫成繁體中文摘要，並附官方全文連結，方便在表格中直接打開閱讀。本稿並非論文全文，亦不是出版社官方譯本；訂閱期刊只能連到摘要或出版社頁面。

編號	題目	取用
01	支氣管哮喘艾灸療法的療效與安全性：系統回顧與網絡 Meta 分析	公開全文
02	針灸聯合常規護理治療多囊卵巢綜合徵合併月經稀發：先導隨機對照試驗	公開全文
03	中醫運動療法對長者衰弱的效果及運動處方特徵描述：系統回顧與 Meta 分析	需訂閱
04	急性缺血性中風溶栓後早期針灸的療效與安全性：隨機對照試驗 Meta 分析	公開全文
05	艾灸治療糖尿病周圍神經病變的療效與安全性：32 項隨機對照試驗系統回顧	需訂閱

公開全文：第 01 篇可經 PMC 閱讀；第 02 篇可經 DovePress／PMC 閱讀；第 04 篇可經 PMC 閱讀。第 03、05 篇為訂閱期刊，本 PDF 只提供中文摘要與官方連結。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 01 篇 公開全文

支氣管哮喘艾灸療法的療效與安全性：系統回顧與網絡 Meta 分析

Efficacy and safety of moxibustion therapy for bronchial asthma: a systematic review and network Meta-analysis

作者	Zheng Haizhen, Chen Baohao, Zou Hanlin, Li Yingjie, Wu Wenzhe, Huang Guomin
期刊	Journal of Traditional Chinese Medicine（2026年10月；46卷5期，頁 1047–1060）
識別碼	PMID 42958657 • DOI 10.19852/j.cnki.jtcm.20260910.001 • PMC13684388
取用	公開全文（PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13684388/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42958657/
- DOI https://doi.org/10.19852/j.cnki.jtcm.20260910.001

研究是什麼

系統回顧並以成對分析及網絡 Meta 分析，比較不同艾灸療法治療支氣管哮喘的療效與安全性，結局包括有效率、肺功能及免疫指標。

方法要點

- 檢索五個資料庫至 2025 年 7 月 27 日，納入評估艾灸治療支氣管哮喘的隨機對照試驗。
- 共納入 44 項 RCT，合計 3,401 名受試者。
- 以 Cochrane RoB 2 評估偏倚風險，並以 Stata 18 及 R 進行成對及網絡 Meta 分析。

主要結果

- 熱敏灸在長期第一秒用力呼氣容積（FEV_1）優於常規治療，標準化均差（SMD）0.45（95% CI 0.03 至 0.87）；哮喘控制測驗（ACT）平均差 0.81（95% CI 0.20 至 1.42）。
- 艾灸聯合常規治療，在提高有效率、改善肺功能與 ACT，以及調節免疫指標方面，整體優於單用常規治療。
- 累積排序（SUCRA）：間接灸在總有效率較前；常規治療聯合熱敏灸在肺功能、ACT、免疫球蛋白 E 及 CD4+/CD8+ 比值較前；常規治療聯合傳統懸灸在降低白介素-6（IL-6）較前。
- 所有與艾灸相關的不良事件均為輕微。
- 作者認為，與單用常規治療相比，聯合艾灸顯示整體優效；惟納入研究質量有限，需更高質量試驗驗證。

中醫診所臨床啟示

- 已診斷支氣管哮喘或喘證患者，可將艾灸（尤其熱敏灸或間接灸）作為吸入藥物等常規治療的輔助選項討論。
- 不能取代急救吸入藥或急性發作處理；出現急性氣促、發紺、說話困難或意識改變，須立即轉急症。

- 網絡排序只供參考，並非「最佳方案」的證明，須向患者說明證據質量有限。

限制與解讀注意

- 納入試驗方法學質量有限，網絡排序可能受異質性及偏倚影響。
- 長期效應主要見於熱敏灸與常規治療的部分比較，不宜外推至所有艾灸手法。
- 安全性結論僅反映已報告的輕微不良事件，急性重症哮喘患者不在本分析的門診適用範圍。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 02 篇 公開全文

針灸聯合常規護理治療多囊卵巢綜合徵合併月經稀發：先導隨機對照試驗

Effect of Acupuncture Plus Usual Care versus Usual Care Alone for Oligomenorrhea in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Pilot Randomized Controlled Trial

作者	Li J, Yang C, Zhang J, Yang L, Hang T, Wang X, An D, Kim PW, Jung SY, Jun P, Kwon O, Lee JM, Lee CH, Zhao J, Fang Y, Xu H, Lee JH
期刊	International Journal of Women's Health（2026年10月22日發表；卷 18，文章 638897）
識別碼	PMID 42936675 • DOI 10.2147/IJWH.S638897 • PMC13701121 • ClinicalTrials.gov NCT04509817
取用	公開全文（DovePress／PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- DovePress 全文 https://www.dovepress.com/effect-of-acupuncture-plus-usual-care-versus-usual-care-alone-for-olig-peer-reviewed-fulltext-article-IJWH
- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13701121/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42936675/
- DOI https://doi.org/10.2147/IJWH.S638897

研究是什麼

國際多中心、平行兩臂先導隨機對照試驗，在中國及韓國共三間門診，評估手法針灸加上常規護理（生活指導），相對於單用常規護理，對多囊卵巢綜合徵（PCOS）合併月經稀發女性月經頻率的影響，並觀察安全性。

方法要點

- 篩選 99 人，入組並隨機 60 人（每組 30 人）；其後對照組 2 人因基線誤診被排除出全分析集（FAS）。針灸組 22 人（73.3%）、對照組 25 人（83.3%）完成試驗。
- 納入 20–40 歲、符合 Rotterdam 標準且月經周期大於 35 日或每年少於 8 次的女性。
- 針灸組於 16 周內接受約 40 次標準穴位手法針灸，並加生活指導；對照組只接受生活指導。主要結局為基線至第 16 周每月月經次數的平均改變；次要結局屬探索性。
- 因干預性質，針灸師及受試者未能致盲；結局評估者及統計人員保持盲態。

主要結果

- FAS（針灸 30 人、對照 28 人）：針灸組月經頻率較對照組多改善 0.20 次／月（95% CI 0.11 至 0.28；P=0.002）。
- 周期長度亦較對照組多縮短 19.69 日（95% CI −29.42 至 −9.97；P<0.001）。
- 無嚴重不良事件。針灸組有 3 例治療相關皮下出血，對照組有 2 例輕微頭痛，均自行緩解。

- 第 32 周（停針後）月經頻率組間差不再顯著（均差 0.14；95% CI −0.06 至 0.34；P=0.646）。作者強調屬先導試驗，結果應視為初步。
- 體重指數、激素及超聲波等其他次要結局，在第 16 或 32 周均無顯著組間差異。

中醫診所臨床啟示

- 月經稀發或 PCOS 門診患者，可將針灸作為生活調理的輔助討論，並說明療效可能隨停針而減退。
- 本試驗未設假針對照，且未能對患者及針灸師致盲，對照組優勢須審慎解讀。
- 不能取代必要的內分泌評估、促排卵或生殖專科處理；妊娠或急性婦科情況須轉介。

限制與解讀注意

- 樣本量按先導試驗設計，統計效能有限；整體脫落率 21.7%，部分與新冠隔離有關。
- 基線月經頻率及周期長度兩組並不完全均衡，主要結局已用共變量分析校正，但仍須謹慎解讀。
- 改善月經頻率並不等於已確認恢復排卵；未按 PCOS 表型分層。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 03 篇 需訂閱／付費

中醫運動療法對長者衰弱的效果及運動處方特徵描述：系統回顧與 Meta 分析

Effectiveness of Traditional Chinese Medicine Exercise Therapy for Frailty in Older Adults and Descriptive Summary of Exercise Prescription Characteristics: A Systematic Review and Meta-Analysis

作者	Huang X, Xin B, Wang R, Cui J, Li M, Jiang W, Zhou H
期刊	Journal of the American Medical Directors Association（2026年11月2日線上發表；27卷12期，文章 106521）
識別碼	PMID 42971076 • DOI 10.1016/j.jamda.2026.106521
取用	需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42971076/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.jamda.2026.106521

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估中醫運動療法對 60 歲或以上衰弱、衰弱前期或符合條件的認知衰弱長者，在衰弱相關結局上的效果，並描述運動處方特徵。

方法要點

- 檢索八個資料庫，由建庫至 2026 年 3 月 31 日。
- 納入社區、院舍或臨床場所的隨機對照試驗。
- 兩名研究者獨立篩選、提取資料並評估偏倚風險；對主要結局分別進行隨機效應 Meta 分析，效應量以經 Hedges' g 校正的標準化均差（SMD）表示。
- 共納入 21 項研究，其中 15 項納入主要 Meta 分析。公開摘要未列出總樣本量。

主要結果

- 中醫運動療法對 Edmonton 衰弱量表（SMD 0.55，95% CI 0.04 至 1.06）、Fried 衰弱表型評分（SMD 2.70，95% CI 1.15 至 4.25）、計時起走測驗（SMD 0.75，95% CI 0.17 至 1.33）、Berg 平衡量表（SMD 1.32，95% CI 1.00 至 1.64）及蒙特利爾認知評估 MoCA（SMD 1.02，95% CI 0.63 至 1.41）顯示有利效應。
- 步速無顯著改善；握力僅見較小且不精確的效應。
- 部分結局異質性高。太極與八段錦是最常出現的運動形式；各研究報告的運動處方特徵並不一致。
- 作者認為，中醫運動療法可能有助部分衰弱、活動、平衡及認知結局，但異質性及部分結局證據有限，須謹慎解讀；處方特徵只屬描述性，不能當成已優化的頻率、強度或進階方案。

中醫診所臨床啟示

- 衰弱或衰弱前期長者，可在體力許可下鼓勵練習太極或八段錦，作為平衡及活動訓練的輔助。

- 須按個別體能、跌倒風險及共病調整強度；急性感染、未穩定心肺疾病或嚴重骨關節損傷者，應先經評估。
- 向患者說明：這是綜合分析而非單一標準處方，效果因人而異，不能取代必要的復康或內科處理。

限制與解讀注意

- 公開摘要未提供總樣本量，解讀時須保留此限制。
- 部分結局異質性高，合併效應可能受個別試驗影響。
- 期刊需訂閱，本摘要只根據已核實的 PubMed 摘要撰寫，完整方法學細節請以出版社全文為準。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 04 篇 公開全文

急性缺血性中風溶栓後早期針灸的療效與安全性：隨機對照試驗 Meta 分析

Early Acupuncture Following Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials on Efficacy and Safety

作者	Li G, Zhou Y, He Z, Li S, Bai Q, Fan S, Chen X, Yue M, Yang X, Shi J
期刊	Brain and Behavior（2026年11月；16卷11期，e71840）
識別碼	PMID 43002125 • DOI 10.1002/brb3.71840 • PMC13746989 • PROSPERO CRD420261358943
取用	公開全文（PMC）

官方連結（點擊即可打開）

- PMC 全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13746989/
- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/43002125/
- DOI https://doi.org/10.1002/brb3.71840

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估急性缺血性中風患者在靜脈溶栓後早期開始針灸，相對於溶栓加常規治療，對神經功能、日常生活活動能力及安全性的影響。

方法要點

- 檢索資料庫及試驗註冊，由建庫至 2026 年 3 月 31 日。
- 納入發病 14 日內、比較「溶栓＋針灸」與「溶栓＋常規溶栓後護理」的隨機對照試驗。
- 以均差或風險比及 95% 信賴區間進行統合；以 I^2 評估異質性，並預先設定亞組分析。
- 共納入 10 項試驗、1,116 名患者。納入研究以 RoB 2 評估，整體均被判斷為「部分關注」。

主要結果

- 輔助針灸使美國國立衛生研究院卒中量表（NIHSS）多下降 2.90 分（95% CI −3.62 至 −2.17），Barthel 指數多上升 12.07 分（95% CI 8.10 至 16.03），臨床反應率風險比 1.16（95% CI 1.11 至 1.21；均 P<0.001）。
- 不良事件組間無顯著差異（風險比 0.52，95% CI 0.25 至 1.08）。僅 1 項研究報告症狀性顱內出血（針灸組 0 例，對照組 6 例）。
- 作者指出，多數試驗未系統監測症狀性顱內出血。GRADE：NIHSS 證據確定性為低，Barthel 指數為極低，臨床反應率為中等，不良事件為低。
- 作者認為結果支持進一步以更嚴謹、有充分安全監測的隨機試驗評估溶栓後早期針灸。

中醫診所臨床啟示

- 急性中風溶栓屬醫院處理，社區中醫診所不宜自行介入超早期治療。

- 本稿只可作為康復階段與神經科協調針灸輔助的背景資料，不能外推至未接受溶栓，或發病超過本分析時窗的患者。
- 不能把「不良事件無顯著差異」解讀為已證明不增加出血風險，因為大多數試驗缺乏系統性出血監測。

限制與解讀注意

- 納入研究整體偏倚為「部分關注」，NIHSS 與 Barthel 指數異質性高、證據確定性偏低。
- 症狀性顱內出血的系統監測不足，安全性結論不完整。
- 試驗多在特定臨床路徑下進行，與本港急症及復康流程未必直接對應。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。

今日論文 • 第 05 篇 需訂閱／付費

艾灸治療糖尿病周圍神經病變的療效與安全性：32 項隨機對照試驗系統回顧

Efficacy and safety of moxibustion in the treatment of diabetic peripheral neuropathy: A systematic review of 32 randomized controlled trials

作者	Liang J, Yuan L, Li W, Wang H, Yan D, Yu J
期刊	Complementary Therapies in Clinical Practice（2026年11月3日線上發表；65卷，文章 102094）
識別碼	PMID 42987539 • DOI 10.1016/j.ctcp.2026.102094
取用	需訂閱／付費

官方連結（點擊即可打開）

- PubMed 摘要 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42987539/
- DOI（出版社全文，可能需訂閱） https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2026.102094

研究是什麼

系統回顧與 Meta 分析，評估艾灸相對於非艾灸療法，治療糖尿病周圍神經病變（DPN）的療效與安全性。

方法要點

- 檢索七個資料庫，納入比較艾灸與非艾灸療法的隨機對照試驗，並以 Cochrane RoB 2 評估偏倚風險。
- 進行隨機效應 Meta 分析、試驗序貫分析（TSA）、敏感性分析、剪補法及亞組分析。
- 共納入 32 項 RCT，合計 2,545 名受試者。

主要結果

- 相對對照，艾灸顯著提高治療反應（比例比值比 3.74，95% CI 3.00 至 4.65）。
- 並改善正中神經及腓總神經的感覺與運動神經傳導速度，減輕 DPN 症狀嚴重程度，降低丙二醛（MDA）、升高超氧化物歧化酶（SOD）活性。
- 血液流變方面，艾灸降低血漿黏度以及低切變與高切變全血黏度，但對纖維蛋白原無顯著影響。公開摘要未列出各項神經傳導速度的具體差值。
- 試驗序貫分析、剪補法及敏感性分析支持部分發現，惟若干結局在排除高偏倚風險研究或考慮不精確性後較為敏感。
- 亞組分析提示，使用足三里或三陰交，以及療程達 4 周或以上的研究，在部分神經傳導結局上改善較明顯。
- 安全性資料有限：僅 4 項試驗提供安全性信息，該 4 項均未報告不良事件。

中醫診所臨床啟示

- 消渴病痹證或糖尿病周圍神經症狀患者，可將艾灸作為血糖控制及常規西藥的輔助討論，並與內分泌科或家庭醫生協調。
- 不能取代降糖治療、足部護理或血管評估；出現潰瘍、感染、急性缺血或迅速加重的感覺／運動缺損，須及時轉介。
- 向患者說明：有效率優勢來自綜合分析，神經傳導的具體差值未在摘要列出，且安全性報告不完整。

限制與解讀注意

- 公開摘要未提供各神經傳導結局的具體均差，本稿不臆測數值。
- 僅少數試驗報告不良事件，不能據此斷言艾灸在此適應症中必然安全。
- 期刊需訂閱，本摘要只根據已核實的 PubMed 摘要撰寫，完整數據請以出版社全文為準。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。